

Wczesne sygnały + plan

Nawroty nie są niespodzianką. Mają sygnały — bezsenność, niepokój, izolacja — pojawiające się 1–4 tygodnie przed epizodem. Jeśli je znasz i działasz, możesz zapobiec hospitalizacji.

CZAS: 15 min · do aktualizacji co 3–6 mies. Po pierwszym epizodzie · z bliskimi

ŹRÓDŁO: Birchwood i in. (1989); Robinson i in. (1999); Gumley & Schwannauer (2006)

JAK UŻYWAĆ

Wypełnij **swoją osobistą sygnaturę nawrotu** w trzech fazach (sekcja 2) — wykorzystaj wiedzę z poprzednich epizodów i pytaj bliskich. Następnie zbuduj **plan trzech poziomów** (sekcja 3, „zielony — żółty — czerwony”). Aktualizuj co 3–6 miesięcy.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Birchwood i in. (1989, „early signs”): każda osoba ma **indywidualną sygnaturę nawrotu** — własną sekwencję subtelnych zmian poprzedzających epizod o 1–4 tygodnie. Najczęstsze: zaburzenia snu, niepokój, drażliwość, izolacja. Wczesne wykrycie i interwencja (kontakt z psychiatrą, modyfikacja leku, redukcja stresorów) **redukuje hospitalizację o 50%**. Robinson i in. (1999): odstawienie antypsychotyku zwiększa ryzyko nawrotu **5-krotnie**. Każdy nawrót zwiększa ryzyko kolejnego (hipoteza zapłonu, ang. *kindling hypothesis*) — dlatego profilaktyka pierwszego nawrotu jest szczególnie ważna.

01 Co zwiększa, co zmniejsza ryzyko nawrotu

ZWIĘKSZA

- Odstawienie leku (5× wyższe ryzyko, Robinson 1999)
- THC, alkohol, amfetamina
- Brak snu, deprywacja
- Wysoka EE w rodzinie (krytyka, wrogość)
- Stresory życiowe nieobsłużone
- Izolacja społeczna

ZMNIEJSZA

- Regularny lek (adherencja > 80%)
- Sen 7–9 h, abstynencja od substancji
- Plan profilaktyczny z wczesnymi sygnałami
- Interwencja rodzinna (NICE: 10+ sesji)
- Wsparcie społeczne, peer-support
- Regularne kontrole psychiatryczne

02 Moja sygnatura nawrotu — 3 fazy

Każdy ma własną sekwencję. Pytaj bliskich, co zauważyli przed poprzednim epizodem — często oni widzą wcześniej niż my sami. Wczesne sygnały rzadko bywają „dziwne” — częściej to *codzienne rzeczy w nasilonej formie*.

WCZESNE (1–4 TYG. PRZED)

— bezsenność, niepokój, podejrzliwość, izolacja, trudna koncentracja

POŚREDNIE (DNI PRZED)

— dziwne myśli, nasilone głosy, paranoja, zaniedbanie higieny

PÓŹNE (EPIZOD)

— pełne urojenia, dezorganizacja, pobudzenie lub zahamowanie

03 Plan trzech poziomów — co robię na każdym

ZIELONY · STABILNOŚĆ

- Codzienny lek o stałej porze
- Sen 7–9 h
- Rutyna dnia
- Aktywność fizyczna 3×/tydz.
- Kontakt społeczny
- Kontrola psychiatryczna co 1–3 mies.

ŻÓŁTY · WCZESNE SYGNAŁY

- Zadzwoń do psychiatry **tego dnia**
- Poinformuj 1 bliską osobę
- Zwiększ sen, redukcuj kofeinę
- Odłóż duże decyzje
- Unikaj stresorów
- Ogranicz kontakty zwiększające stres

CZERWONY · NASILENIE

- Pilna wizyta psychiatryczna lub SOR
- Zaufana osoba przejmuje decyzje
- Plan kryzysowy aktywny
- 116 123 (24/7) · 112 · CZP
- Nie zostawaj sam/-a
- Powiadom rodzinę

04 Moje kontakty kryzysowe

MÓJ PSYCHIATRA / PORADNIA

— imię, telefon, godziny

BLISKA OSOBA — PIERWSZY KONTAKT

— imię, telefon

-------------	-------------

Stale numery: 116 123 (Telefon Zaufania, 24/7) · 112 (Pogotowie) · 988 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży) · SOR psychiatryczny w Twoim mieście · Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)

Klucz: Robinson i in. (1999, badanie z 5-letnim *follow-up*): **odstawienie antypsychotyku zwiększa ryzyko nawrotu pięciokrotnie**. *Adherencja lekowa* to najważniejszy pojedynczy czynnik profilaktyczny. Birchwood (1989): wczesne sygnały są wykrywalne *1–4 tygodnie przed epizodem* — to wystarczająco długo, by zadziałać. Każdy nawrót zwiększa ryzyko kolejnego (*kindling*) i pogarsza długoterminowe funkcjonowanie. **Plan profilaktyki to nie pesymizm** — to praktyczne narzędzie, które daje kontrolę. Najlepsze plany powstają w *okresie stabilności*, kiedy umysł jest jasny, a nie w trakcie nasilenia.